

Généralités Abord et examen clinique d'un patient 2ème partie



Université Constantine 3. Faculté de médecine
Département de médecine.
Enseignement 3ème année médecine.
Année universitaire 2020-2021. . Dr Kerouaz. N

Objectifs du cours

- Comprendre le déroulement d'un examen clinique:
 - En identifiant les quatre temps de l'examen physique:
 - **Inspection**
 - **Palpation**
 - **Percussion**
 - **auscultation.**
 - Distinguer un examen clinique normal d'un examen clinique pathologique.
 - Initiation aux gestes pratiques simples.

Plan du cours

I. Règles générales

II. Les techniques de base de l'examen physique:

- Inspection
- Palpation
- Percussion
- auscultation.

III. Séquence de l'examen physique

I. Règles générales

1. Préparation

- Mettre le patient en **confiance**
- L'installer **Confortablement**
- Patient déshabillé, allongé
- Respecter **son intimité et sa pudeur**
- le respect de la **confidentialité**
- Salle bien **éclairée**, chauffée / climatisée
- Un environnement **silencieux**
- **Disponibilité**
- **Mesures d'hygiène:** Lavez-vous les mains, avant et après l'examen
- L'examineur se **tient à droite du patient** et utilise sa main droite pour la plus part des manœuvres

2. Matériel pour l'examen physique

- **Stéthoscope** : Auscultation
- **Appareil de mesure de la pression artérielle**
- **Thermomètre**: Mesure de la température corporelle
- **Mètre ruban, abaisse langue, lampe de poche**
- **Marteau à reflexe**: Tester les reflexes ostéo-tendineux
- **Diapason 128 Hz**: Tester la sensibilité vibratoire (pallesthésie)
- **Montre marquant les secondes**: Mesure de la fréquence cardiaque et respiratoire
- **Pèse personne, toise**: poids/ taille et calcul du BMI
- **Bandelettes** : Analyse d'urine
- **Gant et lubrifiant**: Toucher rectal
- Oto-ophtalmoscope si possible
- **Stylo, papier.**

Matériel pour l'examen physique



Les techniques de base de l'examen

- Notez que l'examen physique pour chaque système ou organe repose sur 4 techniques classiques:

1. Inspection

2. Palpation

3. Percussion

4. Auscultation

1. Inspection

- Très riche en information
- *l'examinateur doit s'entraîner à:*
observer
« apprendre à l'œil à voir »
- « Ne touchez pas le malade , notez d'abord ce que vous voyez, développez votre sens de l'observation »

Sir William Osler (1849/1919)

1. Inspection

- Observation minutieuse de l'aspect général du patient

- D'abord, une inspection globale : le malade dans son ensemble
- Puis sélective : appareil par appareil
- J'observe: son comportement, état psychique: son humeur, sa mimique
- sa conformation somatique générale
- sa posture
- sa démarche
- sa peau, son état nutritionnel
- la symétrie
- les contours de l'abdomen
- présence d'un œdème des membres inférieurs



Troubles de la posture



Epaule gauche plus haute



1. Inspection

- *Bien connaître certaines attitudes:*

- l'asymétrie du visage en cas de paralysie faciale
- l'aspect soudé du parkinsonien
- le goitre, l'agitation du basedowien, le facies infiltré de l'hypothyroïdien
- le faciès lunaire et une obésité tronculaire du syndrome de cushing.



Maladie de Parkinson ...



Syndrome de Cushing — ...



1. Inspection

- *Bien observer la position du malade:*
 - le cirrhotique est couché sur le dos
 - le cardiaque est assis sur le lit, avec des oreillers, cyanosé et turgescence des jugulaires
 - l'artéritique est assis les jambes pendantes
 - le pleurétique est couché sur le côté malade, il a une toux sèche et brève.

2. Palpation

Est l'utilisation du sens tactile, le toucher

Technique:

- Il s'agit d'une pression exercée avec :
- **la pulpe des doigts**: pulsation vasculaire
- **la face palmaire de la main**: frémissement cardiaque
- **la face palmaire des doigts**: pour déterminer le contour et la taille d'un organe profond (rate , foie), les caractéristiques d'une masse , des adénopathies, d'une tuméfaction, d'une zone douloureuse.

2. Palpation



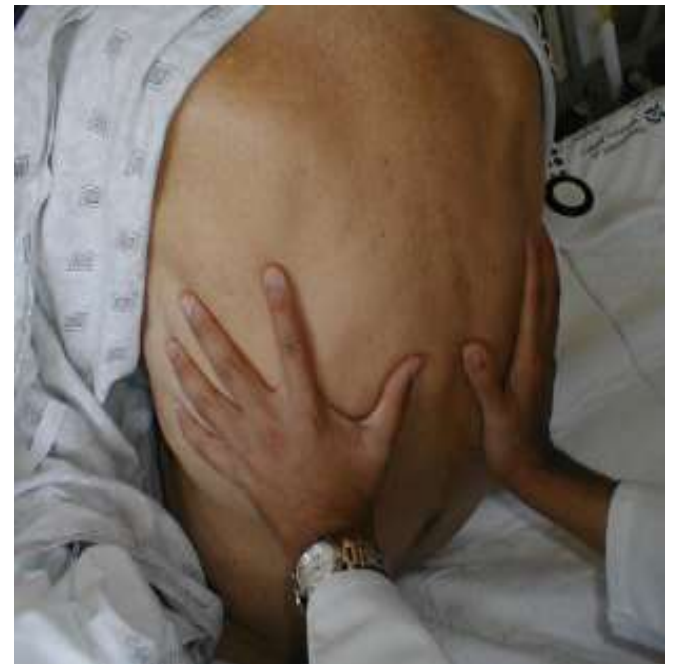
Palpation du foie



Palpation du pouls



Palpation cardiaque



3. Percussion

- Consiste **produire une vibration** , telle qu'une **sonorité** ou **matité** (air, liquide) provenant des organes sous jacents.
- **Technique**: l'utilisation d'un doigt (doigt percuteur), en général le médius droit, pour frapper brièvement: "percuter" extrémité distal d'un doigt de l'autre main en général le médius gauche, posé sur la surface du thorax ou de l'abdomen.
- ex : la percussion d'une matité sur la partie médiane basse de l'abdomen est probablement celle d'une vessie pleine.

3. Percussion

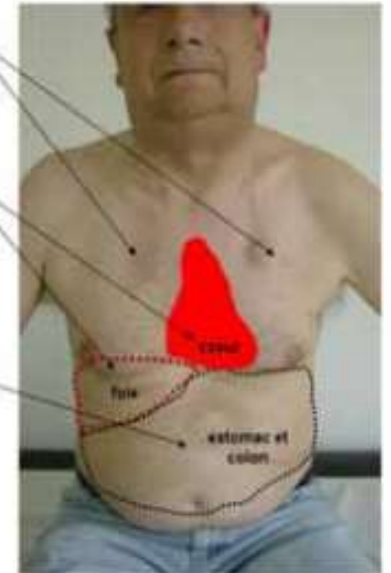


Normal: son clair, sonore

Mat: son diminué, éteint

Tympanique : augmentation
d'intensité (hyper-sonorité)

Ch Marquette



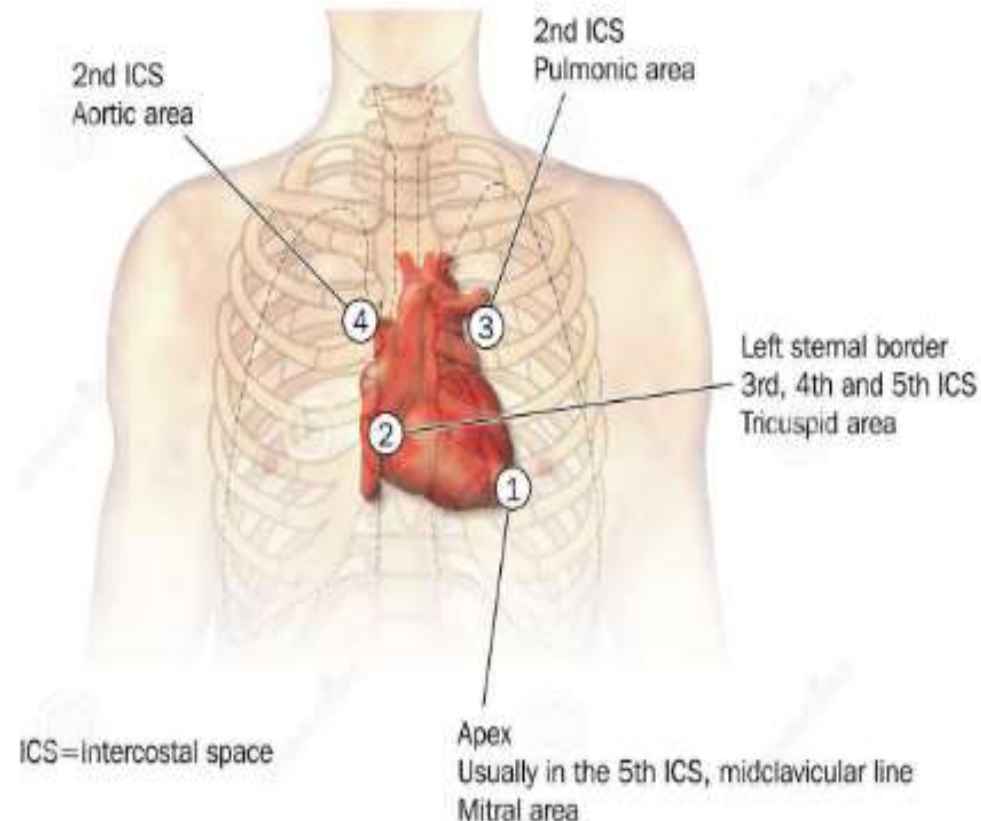
Copyright © 2007 Debra Ayres, M.D.

4. Auscultation

- **C'est l'écoute de son** produit par les organes internes à l'aide d'un **stéthoscope**.
- On ausculte le **cœur, les poumons et artères** (carotides, rénales)
- On peut ausculter également l'abdomen: absence de bruit intestinaux normaux peut traduire une urgence chirurgicale.

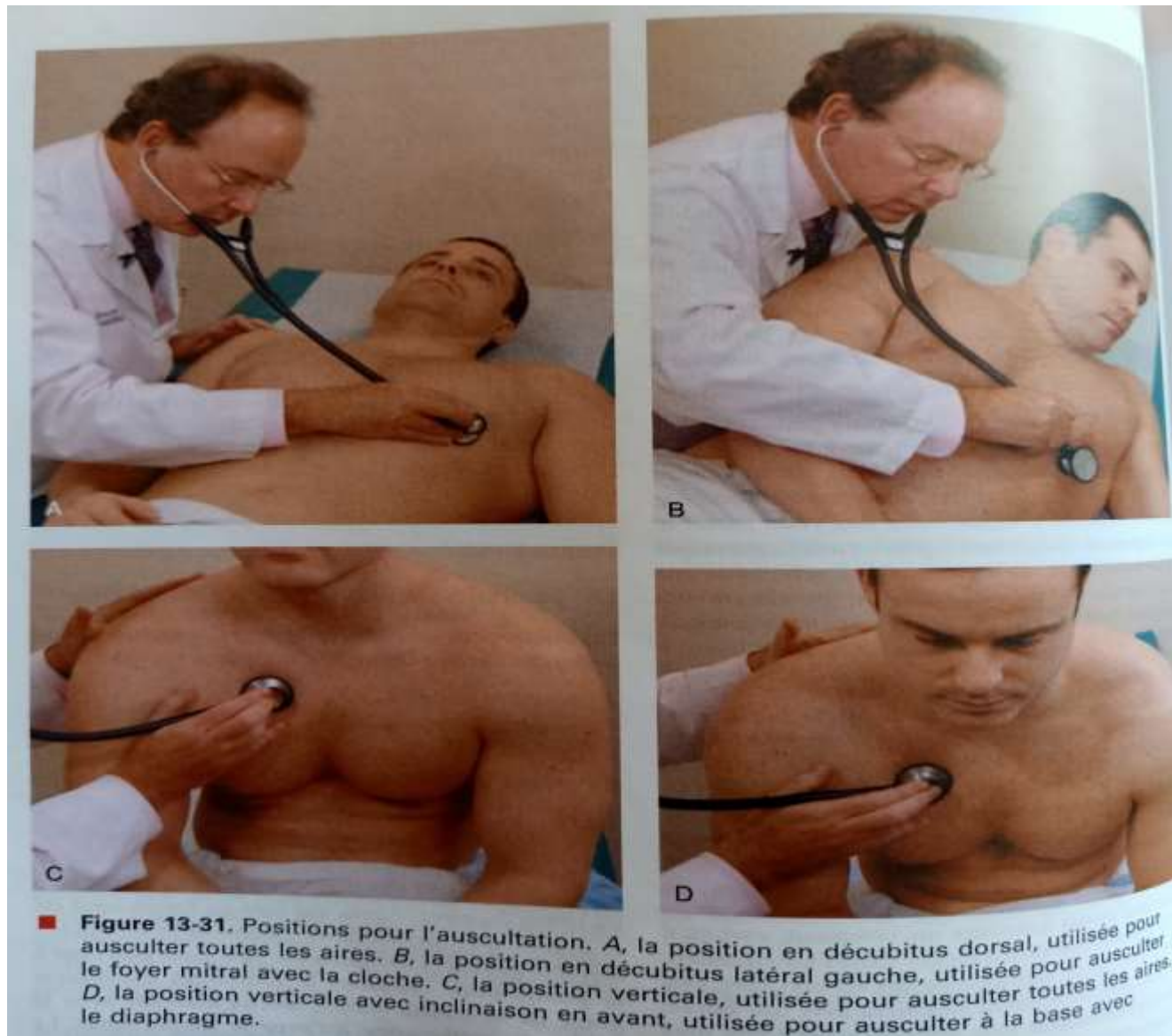
4. Auscultation

- **le cœur**: on déplace le stéthoscope de proche en proche en partant de la pointe vers la base, on identifie **les bruits cardiaques normaux (B1, B2)** correspondant à la fermeture des valves
- On recherche également **les bruits surajoutés, les souffles, un frottement** ou un **assourdissement des bruits**: dû à une péricardite.



4. Auscultation

Auscultation cardiaque



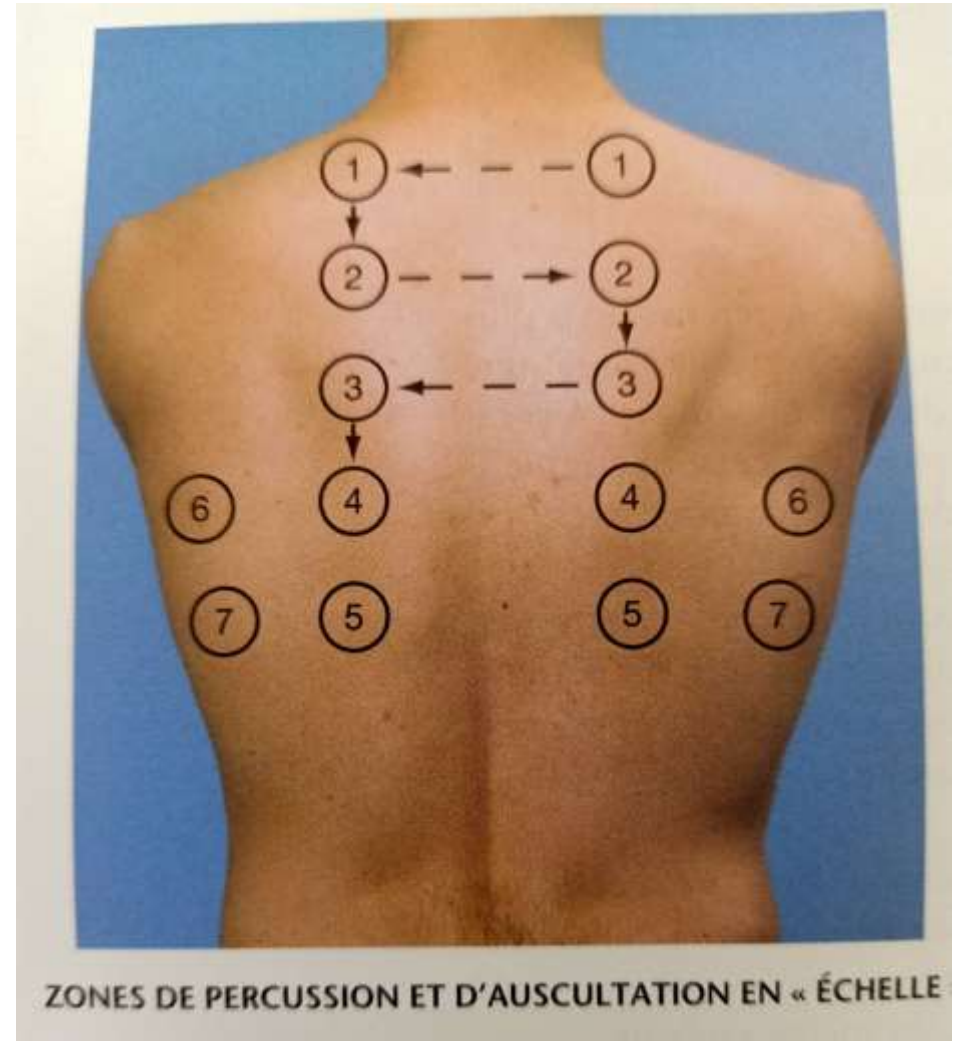
4. Auscultation

- **le poumon:**

l'auscultation se fait de manière comparative au niveau des 2 hémithorax

de haut en bas , sur la face antérieure, postérieure et latérale

on demande au patient de respirer par la bouche :respiration lente et profonde



II. Séquence de l'examen physique

- l'examen est réalisé de façon **méthodique et organisé** de **la tête aux pieds** en expliquant au fur et à mesure les différentes manœuvres au patient.
- On commence toujours par apprécier l'état général, les constantes vitales puis l'examen de la peau ensuite l'examen appareil par appareil.

l'état général

- Appréciation générale sur l'état de santé apparent: bon , moyen ou altéré
- L'état de conscience
- Rechercher les signes de détresse cardio-respiratoire
- l'état d'hydratation: signes de déshydratation
- Coloration de la peau: anémie, ictère, mélanodermie
- Lésions cutanées: nodule, érythème, cicatrice, hippocratismes digital
- La température: syndrome infectieux
- Syndrome œdémateux : signe de godet
- Syndrome hémorragique: purpura, ecchymoses
- Etat nutritionnel: poids / taille et calcul du BMI

l'état général



Examen de la tête

- Teint pâle des anémiques / teint rouge hyper coloré des polyglobuliques
- l'infiltration cutanée du myxoédémateux
- Aspect des phanères: cheveux fins et cassants, alopecie, chute de la queue de sourcils

Examen De La Tête

L'œdème de Quincke se traduit par un gonflement de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés.



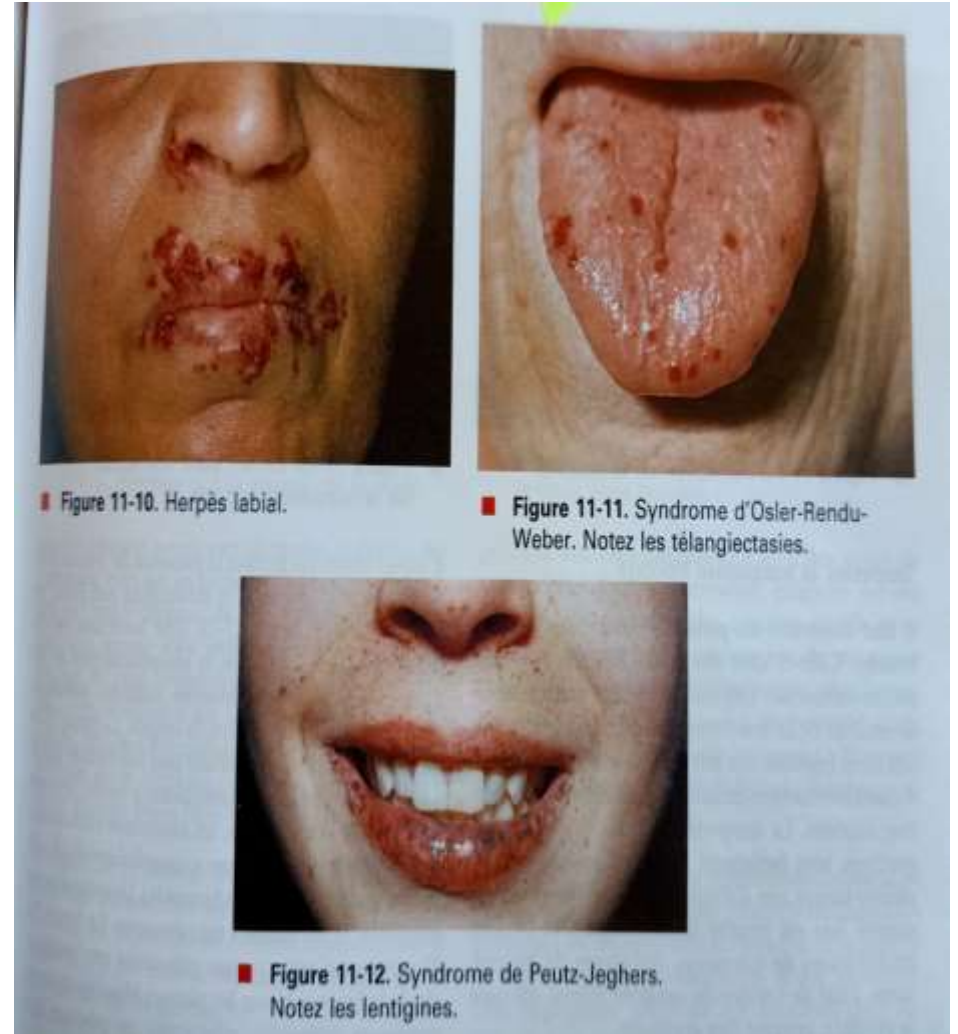
Examen de yeux

- Examen des conjonctives: pâle, ictère
- Xanthélasmas: hyperlipémie
- Exophtalmie
- Ptosis, Strabisme



Examen de la cavité buccale

- *Examen de la langue:*
- Humide et rosée à l'état normal
- Blanche et saburrale dans certaines infections
- Sèche, rôtie : déshydratations
- Lisse décapillée: Biermer: glossite de Hunter
- Rouge, luisante: cirrhose
- Macroglossie: hypothyroïdie, amylose



Examen de la cavité buccale

- *Examen des dents:*
- *Examen de la langue et face interne des joues:*
 - Signe de Koplick de la rougeole
 - Taches ardoisées en cas d'insuffisance surrénale
 - tache blanchâtre: Leucoplasie
 - Glossite :langue rouge dépaillée
- *Examen du pharynx:*
 - Amygdales : volume, couleur, exsudats, fausses membranes



Examen du cou

Nous renseigne sur :

- la glande thyroïde
- Présence d'adénopathies cervicales
- Signes vasculaires : carotides et veines jugulaires
- Signes rachidiens

Inspection:

Elargissement de la base du cou: goitre

Saillie latérale: Adénopathie

Battement exagéré des carotides, turgescence des jugulaires

Palpation: examen de la thyroïde et palpation des aires ganglionnaires
, limitation des mouvements de flexion, extension, rotation

Auscultation: vaisseaux du cou, goitre soufflant

Examen du thorax

- Le torse doit être nu
- **L'inspection** recherche : circulation veineuse collatérale (CVC), œdème en pèlerine évoquant un syndrome cave supérieur, gynécomastie unilatérale: cancer du poumon, une asymétrie thoracique, les modifications du rachis: cyphose, scoliose
Creux sus claviculaire: adénopathie (ganglion de Troisier)
- **Examen de l'appareil cardio-vasculaire**: l'examen normal note: B1B2 audibles, pas de souffles, pas de galop, pas de frottement.
- **Examen respiratoire**: l'examen normal note: thorax est symétrique, une bonne ampliation thoracique, poumons sonores, murmure vésiculaire audible, pas de râles ni sifflements.
- **Examen des seins** (examen gynécologique).

Examen de l'abdomen

- Patient en position de décubitus dorsal, relâché, la tête reposant sur le lit, les membres inférieurs demi-fléchies .
- S'asseoir à droite du malade.

Examen de l'abdomen

- *L' Inspection:*
Volume de
l'abdomen,
voussure, CVC



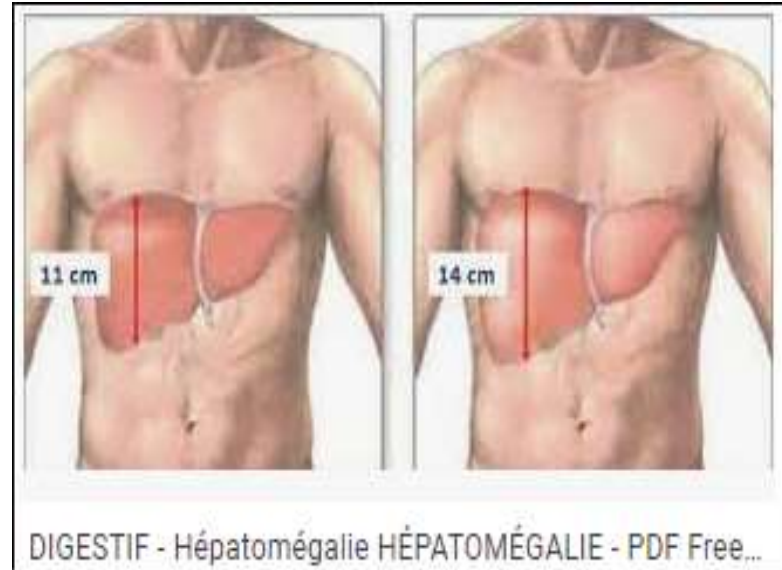
Examen de l'abdomen

- **La palpation** : est **l'étape essentielle de l'examen** , réalisée avec les mains bien réchauffées et posées à plat sur l'abdomen, elle se fait avec la pulpe des doigts en commençant par les zones les moins douloureuse.
- **Elle apprécie** : le tonus de la paroi abdominale:
 - à l'état normal : la paroi est souple
 - une défense ou contracture correspond à une irritation péritonéale.
- **Recherche**: l'hypertrophie d'un viscère (foie, rate), la présence d'une **hernie**, d'une **tumeur**, l'existence de **point douloureux** particuliers.
ex: la manœuvre de Murphy: douleurs vésiculaire
Le point de Mc Burney: appendicite

Examen de l'abdomen

- *La percussion*: En décubitus dorsal et latéral droit et gauche, elle doit être douce
- chez le sujet normal: permet de délimiter le bord supérieur et inférieur de la matité hépatique pour le **calcul de la flèche hépatique**, par ailleurs l'abdomen est sonore.
- anomalies: matité déclive évoquant une ascite.
- *L'auscultation*: apporte peu de renseignements, peut mettre en évidence : un silence auscultatoire: au cours de l'occlusion intestinale, un souffle: en cas compression vasculaire ou d'anévrisme de l'aorte abdominale.

calcul de la flèche hépatique



- C'est la distance qui sépare le bord supérieur du bord inférieur du foie sur la ligne médio-claviculaire.
- Chez l'adulte, la flèche hépatique normale est de 10 à 12 cm
- **L' hépatomégalie** qui se manifeste par une augmentation de la flèche hépatique supérieure à 12cm

Examen des fosses lombaires

A la recherche d'un gros rein, de points douloureux urétéraux, un globe vésical.



Examen de la région anale

- *Inspection* :
- Maladies hémorroïdaires
- Fissure, Fistule
- Condylomes

- *Toucher rectal*: doigtier et lubrifiant
 - Dououreux ou non
 - Hémorroïdes internes
 - Etat de la prostate
 - Recherche de tumeur rectale
 - Sphincter anal
 - Couleur des selles: retroagies, méléna.

Examen des membres supérieurs et inférieurs

- Mensurations des membres
- Examen ostéo-articulaire
- Examen musculaire
- Examen vasculaire
- Examen neurologique

Examen neurologique

- Orientation temporo-spaciale
- Etat de conscience
- Station debout, marche, équilibre
- Étude de la sensibilité superficielle et profonde
- Paires crâniennes
- Déficit moteur, tonus musculaire, reflexes osteo-tendineux

Bibliographie

- Manuel de diagnostic clinique : historique et examen physique, Mark H .Swartz
- Guide de l'examen clinique, Barbara Bates
- Guide pratique de la médecine clinique, Jean-F Letendre
- Sémiologie Médicale. Examen clinique, Pr Malek Rachid
CHU Setif